Nombre: Hernández Silva Roberto Jaziel	**Matrícula**: 1918436
Nombre: Martínez Álvarez Alejandro	**Matrícula**: 2052641
Nombre: Rodríguez Ortíz Danna Saraí	**Matrícula**: 2060308
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 2	**Actividad**: Casos de Negocio
Fecha: 04/09/2026	
Bibliografia (Formato APA) *Caso 01: MediNova. Unidad 2: Análisis de Requerimientos de Negocio.* (2026). [Material de clase].	

Objetivo:

Analizar el caso de negocio de MediNova para identificar sus necesidades, problemas y reglas de operación, mediante el levantamiento de requerimientos, la definición de historias de usuario y criterios de aceptación, con el fin de proponer requisitos claros y verificables para el sistema.

BRD

Contexto

MediNova es una clínica médica privada que opera mediante tres sucursales. Su modelo de negocio se basa en la generación de ingresos a través de consultas de medicina general y especialidades, así como estudios básicos y procedimientos menores, permitiendo a los pacientes pagar de forma directa o mediante convenios con aseguradoras. Operativamente, la clínica es atendida por un aproximado de 35 médicos bajo esquemas mixtos (empleados y por honorarios), lo que genera la necesidad de gestionar horarios altamente dinámicos que cambian semanalmente.

Problema/Oportunidad

El modelo operativo actual de MediNova presenta problemas en la gestión de agendas, lo que ocasiona las citas duplicadas debido a la falta de controles de en sus canales de atención (teléfono, WhatsApp y presencial), existe una poca visibilidad de horarios entre las sucursales, lo que limita la capacidad de citas , horarios y ubicación de pacientes de manera eficiente. Administrativamente , el negocio sufre de una falta de trazabilidad, enfrenta una gran dificultad para medir los 'no-shows' y mantener un historial clínico unificado por paciente.
La oportunidad radica en centralizar la agenda mediante un sistema que valide disponibilidad en tiempo real, registre la auditoría de cada movimiento y automatice la medición del comportamiento de los pacientes.

Criterios de éxito

Reducción de Citas Duplicadas: Reducir a cero (0%) la incidencia de citas duplicadas, garantizando que el sistema valide la disponibilidad de horarios en tiempo real antes de confirmar el registro del paciente.

Visibilidad y Sincronización: Lograr un 100% de disponibilidad de la agenda compartida en línea para que las tres sucursales puedan visualizar y gestionar simultáneamente los horarios de los aproximadamente 35 médicos sin errores de concurrencia.
Trazabilidad de Cancelaciones: Alcanzar un 100% de registro de evidencia en las cancelaciones de citas, asegurando que el sistema no permite borrar una cita sin exigir el motivo, la marca de tiempo y el usuario responsable.

Medición de No-Shows: Automatizar la generación de reportes mensuales de inasistencias (*no-shows*) para medir con exactitud el porcentaje de citas perdidas por sucursal y por médico, consolidando además el historial por paciente.

Optimización de Agendas (Metas de Negocio): Basado en nuestra entrevista simulada, Mantener una meta mensual del 80% de ocupación efectiva de los horarios de consulta, gracias a la capacidad de asignar citas y gestionar el sobrecupo autorizado de manera eficiente.

Alcance

Dentro del alcance:

- Gestión centralizada de la agenda para las tres sucursales, con visibilidad en tiempo real.
- Registro y administración de los horarios dinámicos de los 35 médicos (empleados y por honorarios).
- Módulo de creación, modificación y cancelación de citas a través de los canales de recepción (incluyendo control de concurrencia y prevención de citas duplicadas).
- Registro de llegada de pacientes, gestión de retrasos (hasta 15 minutos) y control automatizado de no-shows y re-agendamientos.
- Generación de historial de citas por paciente y registro de evidencia (auditoría) en cancelaciones.
- Validación básica de convenios con aseguradoras para consultas que requieran autorización previa.

Fuera del alcance:

- Módulo de nómina y pago de honorarios a los médicos.
- Sistema de facturación contable para el pago de los pacientes.
- Expediente Clínico Electrónico (ECE) profundo (solo se registrará el motivo de consulta, la emisión de recetas o la solicitud de estudios básicos y procedimientos menores)

Business requirements/Necesidades

Gestión Centralizada y Concurrencia: El negocio requiere un sistema de agenda única y centralizada que proporcione visibilidad en tiempo real entre las tres sucursales para evitar colisiones y citas duplicadas.
Trazabilidad de Cancelaciones: El sistema debe registrar un historial de auditoría que exija y documente una evidencia clara (motivo, usuario y fecha/hora) cada vez que se cancela una cita.
Gestión Dinámica de Horarios: Se requiere un módulo que permita a los médicos (especialmente a los que trabajan por honorarios) actualizar y registrar sus horarios de disponibilidad que cambian semanalmente.

Control de Historial y No-shows: El negocio necesita un expediente unificado por paciente que permita registrar sus citas previas y medir de forma automatizada sus reincidencias de ausencias (no-shows).
Validación de Sobrecupo y Retrasos: El sistema debe permitir la configuración de reglas de negocio específicas, como la validación para pacientes que llegan hasta 15 minutos tarde y la habilitación de citas en sobrecupo solo para los médicos que lo permiten.

Stakeholders

Paciente: Quien solicita, asiste o falta a las citas médicas.
Recepcionista: Encargada de gestionar la agenda, registrar a los pacientes, confirmar citas y validar retrasos.
Médico: Quien provee sus horarios, atiende la consulta, emite recetas, solicita estudios e indica sobrecupos o nuevas citas.
Personal administrativo: Encargados de gestionar la operación a nivel macro, medir los indicadores de éxito y procesar las cancelaciones de jornadas médicas.
Aseguradora: Entidad externa con la que existen convenios y que en ciertos casos requiere emitir autorizaciones antes de las consultas.

Restricciones

Restricción de Tiempo de Tolerancia: Si un paciente llega hasta 15 minutos tarde, el sistema no puede marcarlo como "atendido" directamente; recepción está obligada a consultar primero al médico para obtener su autorización, de lo contrario se debe ofrecer reagendar.
Restricciones de Aseguradoras: Para los pacientes que utilizan convenios, el flujo de la cita está restringido; algunas aseguradoras exigen obligatoriamente una autorización antes de proceder con ciertas consultas.
Restricción de Sobrecupo: La capacidad de agendar pacientes por encima del límite de la agenda no es global; está estrictamente limitada a las preferencias individuales de cada médico.

Supuestos

Provisión de Horarios: Se asume que los médicos que trabajan por honorarios proporcionarán sus horarios semanales con la anticipación suficiente para que la recepción pueda abrir la agenda al público.
Identidad del Paciente: Se asume que el sistema podrá identificar de manera única a los pacientes existentes (actualmente mediante teléfono o número de expediente) para poder unificar su historial y medir correctamente sus *no-shows*.